

Exposición narrativa gradual

Fase de procesamiento del trauma — solo después de la estabilización (Herman, fase 2).

— CUÁNDO INDICAR

Cuando el paciente ya cuenta con regulación emocional básica, red de seguridad activa y no hay riesgo agudo sin contener. **No se indica** mientras haya ideación suicida activa, consumo problemático sin abordar, o ausencia total de vocabulario emocional.

— OBJETIVO DE LA TÉCNICA

Que el recuerdo traumático pase de ser un fragmento evitado, cargado de vergüenza y nunca puesto en palabras completas, a integrarse como una **narrativa coherente** con principio, desarrollo y fin — reduciendo su carga intrusiva y la evitación asociada.

— PROCEDIMIENTO SUGERIDO

en capas, no de una vez

1

Primera narración, libre y breve

Permitir que cuente lo que ya contó espontáneamente, sin forzar detalle. Validar el coraje de haberlo dicho. No pedir ampliación todavía.

2

Psicoeducación del congelamiento

Explicar la respuesta de congelamiento como reacción biológica normal ante amenaza sin posibilidad de huida o lucha — clave para reducir la autculpa (“*no me defendí*”).

3

Segunda narración, con más detalle sensorial

En una sesión posterior, pedir detalles concretos: dónde estaba, qué vio, qué escuchó, qué sintió en el cuerpo. El ritmo lo marca la activación del paciente, no un guion fijo.

4

Tercera narración, con foco en significado

Una vez que el relato es más estable, trabajar qué significó el evento entonces y qué significa hoy — apuntando a separar la creencia generalizada del evento puntual.

5

Chequeo de activación en cada paso

Antes y después de cada narración, medir activación (0-10). Si supera un umbral que el paciente no puede regular, volver a herramientas de estabilización antes de seguir.

— CLAVE CLÍNICA

No avanzar de capa si el paciente no tiene aún manejo de la activación corporal.